

Diabetes gestacional

1. Introducción y relevancia clínica

La **diabetes gestacional (DG)** es la **intolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostica por primera vez durante el embarazo**, independientemente de que persista o no tras el parto.

En Chile, su prevalencia es de **6–10% de los embarazos**, según la **Guía Perinatal MINSAL 2023**.

Su importancia radica en que se asocia a **macrosomía fetal, parto traumático, hipoglicemia neonatal y riesgo futuro de diabetes tipo 2** tanto en la madre como en el hijo.

El **tamizaje universal** y la **detección precoz** permiten intervenir con medidas nutricionales y, cuando es necesario, con insulinoterapia, reduciendo significativamente las complicaciones perinatales.

□ En EUNACOM, la DG aparece frecuentemente como caso clínico de **embarazada asintomática con glucosa alterada en control de rutina** o como **diagnóstico diferencial en macrosomía o polihidroamnios**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante el embarazo se producen cambios hormonales que **favorecen la resistencia a la insulina**, con el fin de asegurar el aporte de glucosa al feto.

Hormonas implicadas:

- **Lactógeno placentario humano (hPL).**
- **Progesterona.**
- **Cortisol.**
- **Estrógenos.**
- **Prolactina.**

Estas hormonas antagonizan la acción de la insulina, especialmente en el segundo y tercer trimestre, provocando:

- Aumento de la glicemia posprandial.
- Mayor demanda pancreática de insulina.
- Si el páncreas no logra compensar → **diabetes gestacional**.

Fisiopatología fetal:

- La hiperglicemia materna atraviesa la placenta → estimula el páncreas fetal → **hiperinsulinemia fetal**.
 - La insulina fetal actúa como hormona anabólica → **macrosomía, hipoxia e hipoglicemia neonatal postparto**.
-

3. Factores de riesgo

Maternos	Obstétricos previos	Actuales
IMC ≥ 30 kg/m ²	Macrosomía previa (>4 kg)	Polihidroamnios
Edad >30 años	Muerte fetal inexplicada	RCIU o macrosomía actual
Antecedentes familiares DM2	Preeclampsia o parto complicado	Historia de DG previa
Síndrome de ovario poliquístico	—	—

☐ MINSAL recomienda tamizaje universal entre **24–28 semanas**, y precoz (<20 s) si hay factores de riesgo.

4. Diagnóstico

A. Tamizaje universal (MINSAL 2023)

1. Test de O'Sullivan (1 hora, 50 g glucosa VO, sin ayuno)

- Medir glicemia 1 h post carga.
 - **Positivo:** ≥ 140 mg/dL (7,8 mmol/L).
 - Si positivo → realizar **PTOG (curva de tolerancia oral con 75 g)**.
-

B. Test diagnóstico: PTOG 75 g (2 horas, en ayunas)

Según los **criterios IADPSG / MINSAL 2023**, se diagnostica **diabetes gestacional** si **uno o más valores son anormales**:

Tiempo Valor de corte (mg/dL)

Ayuno ≥ 92

1 hora ≥ 180

2 horas ≥ 153

Ejemplo EUNACOM clásico:

Gestante de 28 s con O'Sullivan 152 mg/dL → PTOG: 94-182-150 mg/dL → DG diagnosticada (1 valor anormal).

C. Diagnóstico alternativo precoz (primer trimestre)

Si se detectan valores compatibles con diabetes tipo 2:

- **Ayuno ≥ 126 mg/dL.**
- **Glicemia casual ≥ 200 mg/dL.**
- **HbA1c $\geq 6,5\%$.**

Entonces se clasifica como **diabetes pregestacional**, no gestacional.

5. Clasificación clínica (MINSAL)

Tipo	Descripción	Tratamiento
DG A1	Controlada con dieta y ejercicio	No requiere insulina
DG A2	Requiere insulina para control glicémico	Insulinoterapia

6. Evaluación materno-fetal inicial

Una vez diagnosticada DG, deben evaluarse posibles complicaciones asociadas:

- **Ecografía obstétrica:** crecimiento fetal, líquido amniótico.
 - **Presión arterial:** detección de preeclampsia.
 - **Perfil lipídico y función renal** si glicemias persistentemente elevadas.
 - **Monitoreo fetal:** a partir de 32 s si mal control o uso de insulina.
-

7. Tratamiento

El objetivo es mantener glicemias dentro de rangos fisiológicos **sin hipoglicemias**, promoviendo el bienestar fetal.

A.

Tratamiento no farmacológico (pilar inicial)

- **Plan alimentario personalizado:**

- 30–35 kcal/kg/día (distribuidas en 3 comidas y 2 colaciones).
- Evitar azúcares simples, preferir hidratos complejos y fibra.
- 40–45% carbohidratos, 20% proteínas, 35% grasas.
- **Ejercicio moderado:** caminatas 30 min/día, al menos 5 veces por semana.
- **Control glicémico domiciliario:**
 - Ayuno: <95 mg/dL.
 - 1 h postprandial: <140 mg/dL.
 - 2 h postprandial: <120 mg/dL.

□ Si metas no se logran tras 1–2 semanas → iniciar insulina.

B.

Tratamiento farmacológico

Insulina: tratamiento de elección (no atraviesa la placenta).

Esquemas:

- **Insulina NPH o basal-bolus** con regular según glicemias.
- Dosis inicial: 0,2–0,3 UI/kg/día (ajustar progresivamente).

En Chile no se recomienda metformina como primera línea durante el embarazo (uso restringido).

C.

Monitoreo obstétrico

Control

Frecuencia

Objetivo

Glicemias	Diario (ayuno y postprandiales)	Ajuste terapéutico
Peso materno	Cada control	Evitar ganancia excesiva
Ecografía fetal	Cada 4–6 sem	Crecimiento y líquido
TNS / Doppler	Desde 32 s si uso de insulina	Detectar sufrimiento

D.

Parto y resolución

Situación	Conducta
DG A1, buen control	Inducción a las 40 s
DG A2, con insulina	Inducción 38–39 s
Macrosomía (>4.500 g)	Cesárea electiva
Descompensación metabólica o sufrimiento fetal	Interrupción inmediata

Durante el trabajo de parto:

- Mantener glicemia materna entre **70–110 mg/dL** (insulina IV si necesario).
 - Evitar hipoglicemia neonatal (control precoz del RN).
-

E.

Puerperio y seguimiento

- Suspendir insulina tras el parto (normalmente la glicemia se normaliza).
 - Control de glicemia en ayunas a las **6–12 semanas postparto**.
 - Si normal → tamizaje anual por riesgo de DM2 futura.
 - Anticoncepción: se recomienda **métodos no hormonales o progestina sola**.
-

8. Complicaciones

Maternas

- Preeclampsia.
- Infecciones urinarias recurrentes.
- Polihidroamnios.
- Mayor tasa de cesárea.
- Diabetes tipo 2 a largo plazo.

Fetales y neonatales

- **Macrosomía (>4.000 g)** → trauma obstétrico, distocia de hombros.
- **Hipoglicemia neonatal** (por hiperinsulinemia fetal).
- **Síndrome de dificultad respiratoria**.
- **Ictericia e hipocalcemia neonatal**.
- **Muerte intrauterina** (si DG no controlada).

□ En EUNACOM, la complicación neonatal más típica es **hipoglicemia en RN macrosómico**.

9. Prevención

- Control preconcepcional del peso y glicemia.
 - Tamizaje precoz en mujeres con antecedentes.
 - Educación nutricional durante el control prenatal.
 - Promoción de lactancia materna (reduce riesgo de DM tipo 2 posparto).
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Tamizaje universal con O'Sullivan (50 g, 1 h)** entre 24–28 semanas.
2. **Diagnóstico con PTOG (75 g, 2 h)**: ayuno ≥ 92 , 1 h ≥ 180 , 2 h ≥ 153 mg/dL.
3. **Tratamiento inicial**: dieta + ejercicio.
4. **Si no alcanza metas** → **insulina (no hipoglicemiantes orales)**.
5. Control glicémico ideal: ayuno < 95 mg/dL; 1 h post < 140 mg/dL.
6. **Macrosomía y hipoglicemia neonatal** son las complicaciones fetales más frecuentes.
7. **Repetir tamizaje postparto** a las 6–12 semanas.



Errores comunes

- No realizar tamizaje universal.
- Indicar metformina sin control obstétrico.
- No ajustar insulina pese a glicemias elevadas.

- No considerar cesárea en macrosomía >4.500 g.
 - No realizar seguimiento postparto (riesgo de DM2).
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **diabetes gestacional** es la intolerancia a la glucosa que aparece por primera vez en el embarazo.
2. **Tamizaje universal con O'Sullivan (50 g)** entre 24–28 s.
3. **Diagnóstico:** al menos un valor anormal en PTOG 75 g (92–180–153 mg/dL).
4. **Tratamiento inicial:** dieta + ejercicio → si no controla, insulina.
5. **Control glicémico:** ayuno <95 mg/dL, 1 h post <140 mg/dL.
6. **Parto:** 38–40 s según control y tipo (A1 o A2).
7. **Seguimiento posparto** con glicemia a las 6–12 semanas (riesgo DM2).